

AFMCP Chap6 방어·수복: 만성 염증 Part 2 — 핵심 요약

1. 핵심 개념

- ATM = 선행인자(Antecedents) + 유발인자(Triggers) + 매개인자(Mediators)
- 만성 염증의 4대 ATM 범주: ① 식이/생활습관 ② 장(DIG IN) ③ 노출/경험 ④ 유전적 요인
- 태아기(prenatal) 노출도 만성 염증 소인을 형성함 — 어머니의 exposome이 중요
- 추가 ATM: 약물(Medications), 외상(Trauma), 독소(Toxins), 감염(Infections)

2. 임상 적용 포인트

- 환자 문진 시 반드시 탐색: ACE(소아기 역경), 유발 사건, 환경 노출 시기
- 가족력 확인: 심혈관 질환, 자가면역, 암 — 단, 유전자는 바꿀 수 있음을 전달
- H. 파일로리 발견 시: 표준 치료 + 식이/생활습관 접근법 병행
- 식사 순서 지도: 단백질+채소 먼저 → 탄수화물 나중 → 인슐린 스파이크 억제
- 녹지 공간 처방: 면역계 조절 효과 입증

3. 주요 메커니즘

식이 → 염증 경로 (6가지):

독소 → 렉틴 → 알레르기/과민 → 초가공식품 → NF-κB 활성화 → 산화 스트레스

장 → 염증 연쇄:

소화 장애 → 장내세균 불균형 → 장 투과성 증가 → 자가면역 개시

NF-κB 억제 식품:

생강, 강황(커큐민), 녹차, 올리브오일, 마늘

4. 임상적 단서

- '그 이후로 건강이 달라진' 시점 탐색 → 노출 또는 감염 가능성
- 직장/가정 내 유사 증상자 → 환경 독소 노출 의심
- EBV/CMV 기왕력, 라임 풍토병 지역 거주 → 스텔스 감염 고려
- 외상성 뇌손상(TBI) → 미주신경 기능 이상 → 장 기능 이상 → 염증 연쇄